Suprarrenales e hipófisis

SEMIOLOGIA · Clase 42 · Cushing, Addison, aldosterona, catecolaminas, acromegalia y diabetes insípida

1 · UNA GLÁNDULA QUE NO SE EXPLORA: SEMIOLOGÍA INDIRECTA

Semiología indirecta
la suprarrenal no se inspecciona, palpa ni ausculta: se deduce del exceso o déficit hormonal

F5
Angiotensina II
contrae arteriolas, estimula la aldosterona y retiene Na+ y agua en el proximal, el asa, el distal y el colector: N.A.

deduce la función de la
y también de la
estimula la aldosterona de la

Corteza
glucocorticoides (cortisol), mineralocorticoides (aldosterona) y esteroides sexuales

Médula
secreta adrenalina y noradrenalina (catecolaminas)

2 · CORTISOL DE MÁS: SÍNDROME DE CUSHING

F1
Causas
adenoma hipofisario (enfermedad de Cushing), tumores ectópicos, carcinoma suprarrenal y corticoides por automedicación

producen el exceso de

F1
Exceso de glucocorticoides
redistribuye la grasa y destruye proteína del músculo y la piel

redistribuye la grasa:
si sobra cortisol:
lesiona la piel:
retiene líquido y sube la
en otros órganos produce
si secreta ACTH, causa el

Figura
cara de luna llena, joroba de búfalo, abdomen pendular y miembros delgados con debilidad proximal

Piel
estrías violáceas, equimosis con golpes mínimos y acné

F4
HTA leve a moderada y edema discreto de cara y tronco

F4
Otras (🛍️)
osteoporosis, diabetes e hiperglobulia; la menos citada en clase es la hiperglobulia

orienta al
orienta al
apoya el
apoya el

Cara de luna y estrías: síndrome de Cushing de cualquier causa; enfermedad si es hipofisario

si sobra aldosterona:

3 · CORTISOL Y ALDOSTERONA DE MENOS: ADDISON

si faltan cortisol y aldosterona:

F1
Corteza destruida
falta cortisol y aldosterona

hace perder sodio y agua:
la hipófisis responde con
si se instala de golpe:
si un tumor la desboca:

Pérdida de sodio y agua
se retiene potasio: sodio bajo y potasio alto

ACTH alta (🛍️)
la hipófisis pide más cortisol y su señal oscurece la piel

Crisis addisoniana: si se instala de golpe, vómitos y shock

se confirma con

F3
Exámenes (🛍️)
cortisol matutino bajo con ACTH alta, prueba de estimulación con ACTH, Na+ bajo, K+ alto e hipoglucemia

produce
oscurece la piel:
confirma el

F1
Hipotensión postural
mareo y síncope al pararse; astenia, pérdida de peso y náuseas

F1
Hiperpigmentación
cicatrices y boca: «boca de perro»

junto a la hipotensión, orienta a
junto a la pigmentación, orienta a

F1
Pigmentación **más** hipotensión o síncope: enfermedad de Addison

4 · ALDOSTERONA DE MÁS: HTA CON POTASIO BAJO

F1
Aldosterona de más
estimulada por la angiotensina II

retiene sodio y pierde potasio:

Retiene sodio y agua en el túbulo y pierde potasio

sube la presión y baja el potasio:
si el potasio cae mucho:
vuelve alcalina la sangre:

F1
HTA con hipopotasemia
cansancio y nicturia; la figura no cambia

Parálisis o flacidez de piernas
si la hipopotasemia es marcada

Alcalosis
hiperexcita el nervio y da tetania

si se suma parálisis:
si se suma HTA:
da tetania, que se busca con

F1
HTA **más** parálisis de piernas: hiperaldosteronismo primario

F2
Signo de Trousseau
manguito sobre la sistólica unos 10 minutos: mano de partero; también Chvostek

si es positivo, hay

F2 · F6
Tetania latente: hipocalcemia, hipoparatiroidismo o alcalosis

5 · CATECOLAMINAS DE MÁS: FEOCROMOCITOMA

F1
Feocromocitoma
tumor de la médula con exceso de catecolaminas

libera catecolaminas en la

Crisis catecolaminérgica
inicio brusco y corta duración

el paciente siente
produce

Cefalea, sudoración y palpitaciones

Vasoconstricción generalizada
igual que en un susto intenso

obliga a medir las catecolaminas:
explica la
se objetiva con

Taquicardia, HTA paroxística y palidez

se confirma midiendo
si persiste, causa

F1
Se **miden las catecolaminas** para confirmar el feocromocitoma

Si el exceso se mantiene: HTA permanente, nefroesclerosis, retinopatía, ACV hemorrágico, miocardiopatía y arritmias

6 · HIPÓFISIS: GH Y PROLACTINA

Adenoma de la hipófisis anterior (🛍️)
más del 95 % de las acromegalias es esporádico

si secreta GH de más:
si secreta prolactina:

F8
GH alta y sostenida
lo normal es pulsátil, con más producción de noche

F6
Prolactina de más (🛍️)
se acompaña de galactorrea, ginecomastia o amenorrea

hace crecer hueso y partes blandas:
trae consigo los términos de

F8
Acromegalia
manos y pies grandes, mandíbula prominente, rasgos toscos e hipertrofia biventricular

F6
Términos
amenorrea: sin regla; ginecomastia: mamas en el varón; galactorrea: leche sin lactar; hipocalcemia: tetania; adipsia: sin sed

por lo lento, se diagnostica

F8
Diagnóstico 7 a 10 años tarde (no 1 año)

7 · ADH DE MENOS: DIABETES INSÍPIDA

ADH
hace que el colector reabsorba agua

si no se produce:
si el riñón no responde:
si lesiona la neurohipófisis:

F9
Central (🛍️)
falta de ADH por lesión hipotalámica o hipofisaria, trauma, cirugía o tumores

F9
Nefrogénica (🛍️)
el riñón no responde a la ADH

impide reabsorber agua en el
impide reabsorber agua en el

Colector que no reabsorbe agua
se pierde en la orina

produce

F7 · F10
Poliuria y polidipsia
orina abundante, diluida, clara y de baja densidad, con nicturia y sed intensa

si no puede beber:
se vigila con la
orienta a la
confirma la

F10
Si no puede beber: deshidratación, hipernatremia, confusión y coma

F7
Prueba de restricción hídrica
se vigila con peso, examen físico y diuresis

F9
Diabetes mellitus (🛍️)
tipo 1: falta absoluta de insulina; tipo 2: resistencia con déficit relativo

no se confunde con la

F7
Orina diluida con sed intensa: **diabetes insípida**, no mellitus

técnica · concepto · mecanismo · causa · signo · desenlace · diagnóstico · síndrome · síntoma · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Tu teoría — 13b Semiología de las glándulas suprarrenales, 05b (tetania y Trousseau), 05k (facies de Cushing); angiotensina II: Guyton; hipófisis y exámenes de Addison: literatura 🛍️